Vivien Schenkel

Psychologische Psychotherapeutin

Psychotherapiepraxis Jurilj & Schenkel
Schoonebeekstraße 1
49124 Georgsmarienhütte

S010993

AN
Die MitarbeiterInnen der endokrinologischen Praxis

08.01.2024

PSYCHOTHERAPEUTISCHE STELLUNGNAHME ZUR GESCHLECHTSANGLEICHENDEN HORMONERSATZTHERAPIE VON FRAU STEINHAUER

Sehr geehrte Mitarbeitende aus der behandelnden endokrinologischen Praxis,

Alina (Vorname im Personalausweis: Nick) Steinhauer stellte sich bei mir in psychotherapeutischer Sprechstunde zur Indikationsstellung für die Hormonersatztherapie vor. Insgesamt haben 2,5 einzeltherapeutische Sitzungen stattgefunden im Rahmen einer Verhaltenstherapie.
Zudem ist eine Anbindung an eine Transpeergroup seit dem 01.12.2023 ebenfalls gegeben. Dort konnte bereits eine erste Aufklärung stattfinden und in Folge eine psychische Stabilisierung erfolgen.

Ich bin psychologische Psychotherapeutin und umfassend fortgebildet in der Transitionsbegleitung, sowie Teilnehmerin an einem deutschlandweiten Qualitätszirkel und regelmäßiger Intervision mit langjährig erfahrenen Kolleg*innen. Gern bin ich daher der Bitte der Patientin nach Diagnostik und Indikationsstellung nachgekommen.
Bei der Patientin liegt nach ICD-11 HA60 („gender incongruence“) mit deutlicher Dysphorie bzw. nach ICD-10 F64.0 (Transsexualismus, Mann zu Frau) vor.
Es liegen abgesehen von einer Genderdysphorie aktuell aus meiner Sicht keine psychischen Störungen vor. Es gibt keine psychotherapeutischen Vorbehandlungen und in Screeningfragebögen, im Selbstbericht sowie auch im Kontakt mit mir keine Hinweise auf psychische Erkrankungen. Drogen- und Alkoholkonsum wird verneint.

Die Patientin beschreibt ihre Transidentität als seit dem Kindergartenalter immer wieder sich manifestierendes Selbstkonzept, auch wenn sie dies am Anfang noch nicht als Transidentität benennen konnte. Erste Erinnerungen aus der Kindergartenzeit bestehen, in der die Kinder nackt im Planschbecken waren und die Patientin sich aufgrund ihres Geschlechts unwohl fühlte und gar nicht ausziehen wollte. In der Schulzeit

waren wichtige Momente Fasching und Halloween, in denen die Patientin sich gerne mit weiblichen Kostümen verkleidet hätte, sich dies aber durch die Erwartungen in ihrer Familie nicht getraut habe. In der Familie habe es eine klare Rollenverteilung gegeben, in die sich die Patientin auch hineingedrängt gefühlt habe. Ein Ausleben ihrer Transidentität schien ihr daher nicht möglich. In ihrer Jugend habe sie heimlich in ihrem Zimmer Crossdressing, Schminken und Nägellackieren ausprobiert. In diesem Momenten habe sie sich immer wohl gefühlt, aber auch Ängste gehabt, erwischt zu werden. Mit 18 Jahren habe sich die Patientin erstmals getraut, das Crossdressing auch außerhalb der Wohnung auszuprobieren, immer mit der Angst erwischt und nicht akzeptiert zu werden. Mit 19 Jahren wurde sie von ihrem Bruder erwischt und es kam zum ersten Outing in der Familie bezüglich des Crossdressings. Die Transidentität kam hierbei jedoch noch nicht zur Sprache, weil die Patientin sich zu diesem Zeitpunkt selbst noch gar nicht mit dem Begriff Transidentität auseinandergesetzt hatte, versuchte das Thema zu verdrängen und hoffte, dass sich ihre Gefühle verändern würden, sodass sie besser in die Gesellschaft und in das Bild ihrer Familie passte. Eine Beziehung (Ehe, Haus und Kind), die seit 9 Jahren besteht, machte ein Ausbrechen aus der männlichen Rolle ebenfalls schwierig. Dies tat sie jedoch immer wieder auch in der Öffentlichkeit. Dabei erlebte sie einerseits ein wohliges, passendes Gefühl aber auf der anderen Seite auch ein schlechtes Gewissen. Das Bedürfnis ihre Transidentität auszuleben wurde immer stärker.

Seit dem 20.11.2023 erlebte Frau S. ihr Geschlecht schließlich als klar formulierte Identität, welche sie sich endlich ohne schlechtes Gewissen eingestehen konnte. Diese lebt sie nun auch seit dem 01.12.2023 vollumfänglich im sozialen Raum, in der Familie, auf der Arbeit und im Freundeskreis, und kommuniziert diese sozial. Alle Outings sind gut verlaufen und die Patientin fühlt sich im engen sozialen Umfeld gut unterstützt. Die einzig negative Veränderung ist die daraus resultierende Scheidung von der derzeitigen Ehefrau - auch wenn diese die Patientin in ihrem Transitionsprozess unterstützen möchte und auch ein freundschaftliches Verhältnis bestehen bleiben wird, ist eine Weiterführung der Ehe aus aktueller Sicht nicht möglich. Die Patientin fühlt sich dennoch nach dem Outing sehr wohl, kann gut mit der negativen Konsequenz umgehen und ist absolut gefestigt in ihrer Transidentität.

Es ist vor diesem Hintergrund davon auszugehen, dass es sich bei der Transidentität um eine stabile Identitätswahrnehmung handelt. Die Patientin tritt soweit dies möglich ist öffentlich und privat in ihrem Identitätsgeschlecht als Frau auf. Die Eigenwahrnehmung löst aktuell eine starke Dysphorie aus, da ihre körperliche Wahrnehmung nicht mit ihrem Identitätsgeschlecht übereinstimmt. Dabei leidet die Patientin am meisten an ihrer fehlenden Brust, der männlichen, muskulösen Körperstatur und der männliche Behaarung, wodurch durch eine Hormonersatztherapie eine deutliche Senkung des Leidensdrucks zu erwarten ist. Außerdem ist noch kein Passing möglich. Dadurch kommt es insbesondere in sozialen Situationen immer wieder zu einem hohen Leidensdruck. Sie hat daher einen stark ausgeprägten, stabilen und eindeutigen Wunsch nach medizinischen Behandlungen, die es ihr ermöglichen, ihren Körper dem Identitätsgeschlecht entsprechend anzupassen.

Eine feminisierende Hormonersatztherapie ist aus psychotherapeutischer Sicht wegen ihrer stabilisierenden und auch das Leiden lindernden Wirkung befürwortet mit dem Ziel, den Körper zunehmend mit dem Identitätsgeschlecht der Patientin in Einklang zu bringen, das Passing sowie Alltagserfahrungen zu ermöglichen und die soziale Integration zu verbessern.

Laut S3-Leitlinie[1] ist eine schnelle Versorgung mit der entsprechenden medizinischen Unterstützung indiziert.

Die Patientin ist psychosozial stabil und unterstützend eingebunden. Sie ist sowohl vor, als auch im Rahmen der psychotherapeutischen Sprechstunde ausführlich über Grenzen und Möglichkeiten einer Hormonersatztherapie informiert. Neben den Wirkungen und Nebenwirkungen der Hormonveränderungen sowie den Auswirkungen und Risiken der unterschiedlichen Präparate wurde insbesondere über die möglichen Auswirkungen auf Zeugungsfähigkeit aufgeklärt und die Option einer Kryokonservierung besprochen und abgewogen. Die Möglichkeiten stimmen mit den Wünschen und Vorstellungen zum nächsten Transitionsschritt der Patientin überein.

Mit freundlichen Grüßen

Vivien Schenkel

[1] AWMF (2019). S3-Leitlinie Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit: Diagnostik, Beratung, Behandlung. (Version 1.1, Stand 22.02.2019)